

## ANAMNESE GYNECOLOGIQUE

### 1. Objectifs :

- Déterminer le ou les motifs de consultations
- Faire décrire la symptomatologie fonctionnelle de la patiente
- Répertorier les antécédents personnels et familiaux

### 2. Motifs de consultations

- Contrôle annuel
- Contraception
- Symptômes précis

### 3. Symptomatologie fonctionnelle

- Algies pelviennes :
  - o Localisation
  - o Irradiation
  - o Type de douleur et intensité (échelle de la douleur)
  - o Date d'apparition et évolution dans le temps
  - o Facteur déclenchant et circonstance d'apparition
  - o Facteurs aggravant ou soulageant
  - o Durée, caractère cyclique, temporalité par rapport au cycle (pendant les règles, milieu du cycle)
  - o Impact fonctionnel (limitation de certaines activités ?)
  - o Signes associés : urinaires, digestifs, mammaires
- Anomalies de saignement
  - o Temporalité : métrorragies, ménorragies, oligoménorrhée, spanioménorrhées
- Aménorrhées
  - o Primaire ou secondaire
- Leucorrhées
  - o Date de début
  - o Périodicité dans le cycle

- Facteurs déclenchants (ttt antibio, changement de partenaire, oestro-progestatifs, ...)
- Caractère des pertes : couleur, abondance, consistance, odeur
- Signes associés : prurit, brulures vulvo-vaginales, troubles urinaires, douleurs abdominales, signes généraux (fièvre, frissons, fatigue, ganglions)
- Symptômes chez le partenaire
- Pathologie mammaire
  - Uni- ou bilatéral
  - Cyclique ou non
  - Écoulement mamelonnaire : sanglant, lacté/séreux, purulent
  - Palpation d'une masse
  - Modification de l'aspect de la peau (rétraction, voussure, ulcération, rougeur, œdème, peau d'orange)
  - Symptômes généraux (baisse de l'état général, perte de poids, ...)
- Troubles associés
  - Urinaires : infection, incontinence
  - Rectaux : constipation, diarrhée, incontinence
- Troubles de la vie sexuelle
  - Dyspareunie : superficielle ou profonde
  - Troubles du désir sexuel

#### 4. Antécédents

- Antécédents médicaux
  - Médicaments
  - Allergies
  - Tabac
  - Diabète, HTA, ...
- Antécédents chirurgicaux
  - Interventions (année, voie d'abord, type d'intervention)
- Antécédents gynécologiques
  - Puberté : âge

- Cycles menstruels : régularité, abondance des règles, durée, syndrome prémenstruel, DDR
- Contraception : actuelle et antérieure
- Infections gynécologiques (HPV, Chlamydia, ...)
- Ménopause : date de survenue, troubles, traitement
  
- Antécédents obstétricaux : gestité, parité, FCS, IVG, types d'accouchement
- Rapports sexuels : partenaire régulier, multiples, dyspareunie
- Dernier contrôle gynécologique
  
- Antécédents familiaux
  - Cancers (col, utérus, sein, digestif, autre)
  - Maladie thrombo-embolique
  - Diabète, HTA, ...

## **EXAMEN GYNECOLOGIQUE**

*! Bien expliquer les étapes de l'examen à la patiente !*

### 1. Examen abdominal

En décubitus dorsal, jambes allongées

- Inspection de la paroi abdominale (voussures, cicatrices, ...)
- Auscultation
- Palpation dans les 4 quadrants (palpation d'une masse? Défense? Détente?)
- Eventuellement, percussion abdominale
- Percussion des loges rénales

### 2. Inspection vulvaire

En position gynécologique, fesses bien au bord de la chaise, jambes relâchées

- Inspection de la vulve, anus, introïtus:
  - o Développement des caractères sexuels secondaires chez une jeune fille
  - o Lésions vulvaires (condylomes, ulcères, kystes, vésicules, ...), cicatrices obstétricales
- Distance ano-vulvaire
- Inspection vulvaire lors d'efforts de poussées (prolapsus ?)

### 3. Examen au speculum

Technique de prise et de pose de speculum :

- Valves du speculum maintenues fermées entre l'index et le majeur de la main D
- Speculum lubrifié avant la mise en place
- Ecartement doux des lèvres avec la main G
- Speculum introduit lames fermées et en position verticale, en prenant appui sur la fourchette vulvaire postérieure
- Eviter la zone urétrale
- En poussant le speculum à l'intérieur, rotation d'un quart de tour

- Au contact du col, ouverture douce et progressive du speculum et ajustement de la lumière



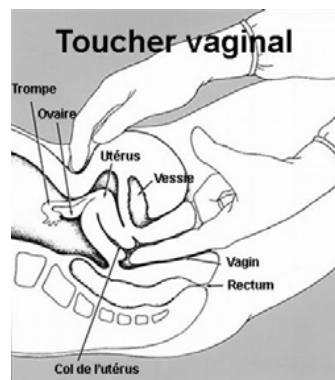
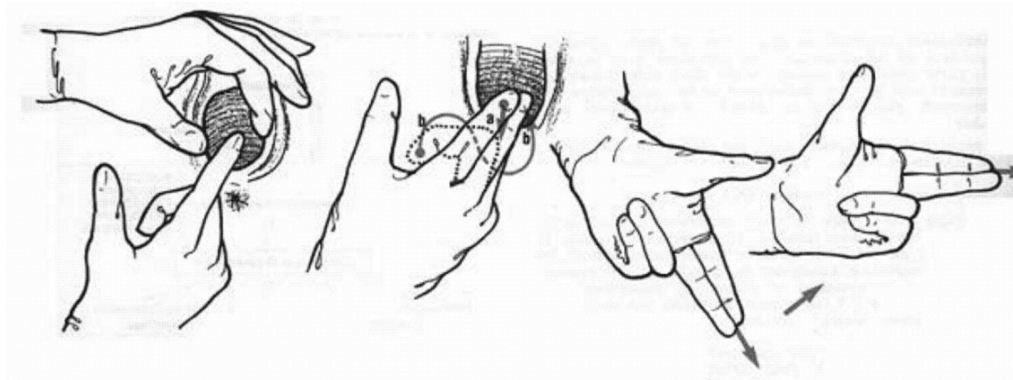
#### Inspection vaginale et cervicale

- Inspection du col: taille, surface, ectropion, polype, saignement, écoulement cervical
- Réalisation du frottis cervical (identification de la zone de jonction, frottis exo- et endocervical), de frottis bactériologiques et d'un examen direct des pertes vaginales
- Inspection des culs de sacs vaginaux et de la paroi vaginale en retirant le speculum doucement et à demi ouvert: fistule, prolapsus, voussures, lésions, ...

#### 4. Toucher vaginal

##### Technique de réalisation du toucher vaginal :

- Utilisation de 2 doigts de la main D (index et majeur) ou 1 seul (index) si atrophie vaginale
- Doigts introduits après écartement doux des lèvres avec la main G, en appuyant sur la fourchette postérieure. Doigts orientés vers le bas et l'arrière.
- Un doigt placé de chaque côté du col avec la main vaginale
- Main G (main abdominale) : ramène vers les doigts vaginaux le contenu viscéral pelvien (utérus et annexes)



Evaluation par le toucher :

- Paroi postérieure de la vessie: sensibilité, masse
- Urètre : écoulement de pus à la pression de l'urètre
- Col utérin : consistance, volume, mobilité, sensibilité, longueur
- Utérus : taille, régularité, mobilité, sensibilité
- Annexes : mobilité, sensibilité, masses
- Cul-de-sac vaginal postérieur : masse ou sensibilité du Douglas

Limites du TV :

- Patientes obèses

## 5. Toucher rectal

Pas systématique



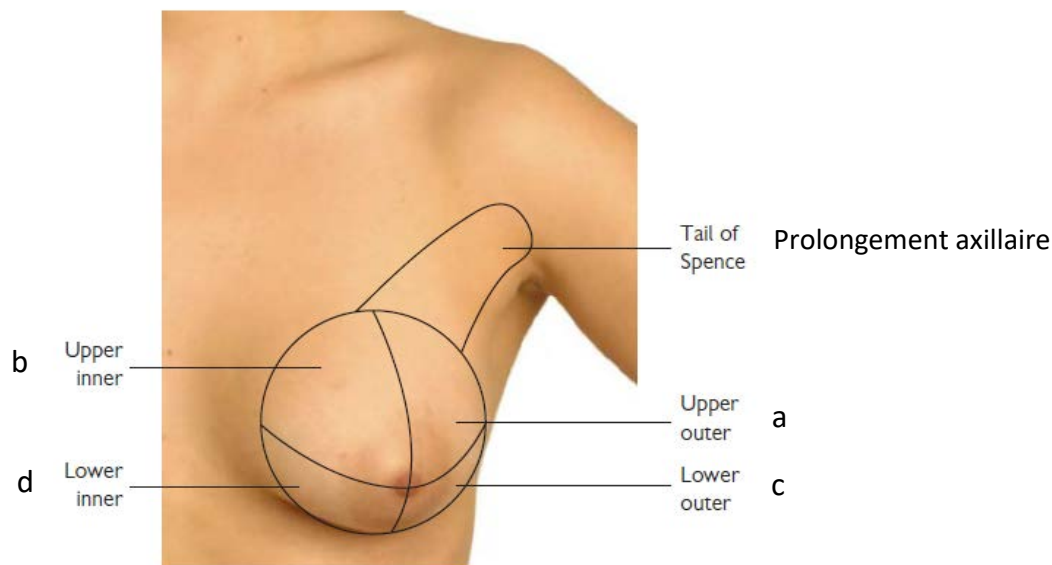
Département femme-mère-enfant  
Service de Gynécologie-Obstétrique

*Unil*  
UNIL | Université de Lausanne

Il peut être combiné au TV pour évaluer la cloison recto-vaginale lors d'endométriose, de cancer, ...

## EXAMEN MAMMAIRE

### 1. Repères anatomiques



- a) QSE : quadrant supéro-externe
- b) QSI : quadrant supéro-interne
- c) QIE : quadrant inféro-externe
- d) QII : quadrant inféro-interne

### 2. Inspection

Symétrie des seins

Anomalie de forme du sein (certaines tumeurs déforment le sein)

Anomalies cutanées (rougeur, rétractions, voussure...)

Aspect de la plaque aréolo-mamelonnaire (mamelon ombiliqué, eczéma du mamelon)

Technique d'inspection :

- Inspection dynamique : patiente en position debout puis assise, bras en bas légèrement écartés puis levés





### 3. Palpation

En position couchée ou semi-assise, bras levés

Deux mains à plat en faisant rouler la glande sur le grill costal

Evaluation quadrant par quadrant

Evaluation de la taille, morphologie, anomalies palpatoires et sensibilité des seins

Recherche d'un écoulement mamelonnaire par pression

Inspection et palpation des aires ganglionnaires :

- Patiente en position assise, bras légèrement écartés du tronc
- Aires axillaires, sous- et sus-claviculaire
- Palpation bilatérale synchrone des aires G et D

## Position pour la palpation mammaire



## Technique de palpation mammaire

